Analyse 3 - Acces aux soins et depenses de sante

Nigeria GHS Panel Wave 4 (2018)

AUTEUR·RICE·S
Abdoul Aziz BA
Parfait Jemmy Prodige NGOYI

DATE DE PUBLICATION
23 mars 2026

1 Introduction

Ce rapport analyse les épisodes de maladie, les types de soins consultes et les couts de santé supportes par les menages nigerians a partir du Nigeria General Household Survey (GHS) Panel Wave 4 (2018). Les données couvrent **26 556 individus** issus de menages urbains et ruraux.

2 Méthodologie

2.1 Sources de données

Le Nigeria GHS Panel est une enquete longitudinale conduite par le National Bureau of Statistics (NBS) du Nigeria en partenariat avec la Banque Mondiale (LSMS-ISA). La Wave 4 couvre la periode 2018-2019.

2.2 Variables analysees

Characteristic	Overall N = 5,703[1]	Homme N = 2,959[1]	Femme N = 2,744[1]
Groupe age			
0-14	2,419 (44%)	1,395 (49%)	1,024 (39%)
15-24	741 (13%)	398 (14%)	343 (13%)
25-34	648 (12%)	233 (8.2%)	415 (16%)
35-49	954 (17%)	414 (15%)	540 (20%)
50-64	551 (10%)	292 (10%)	259 (9.8%)
65+	181 (3.3%)	113 (4.0%)	68 (2.6%)
Unknown	209	114	95

[1] n (%)

Characteristic	Overall N = 5,703[1]	Homme N = 2,959[1]	Femme N = 2,744[1]
Maladie/Blessure			
Non	4,359 (91%)	2,337 (93%)	2,022 (89%)
Oui	439 (9.1%)	187 (7.4%)	252 (11%)
Unknown	905	435	470

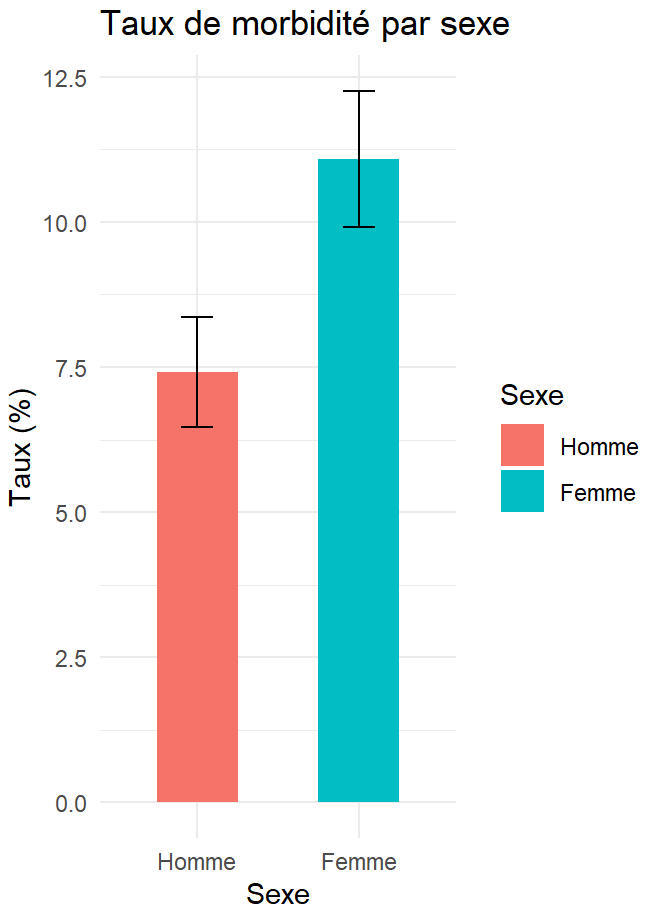
[1] n (%)

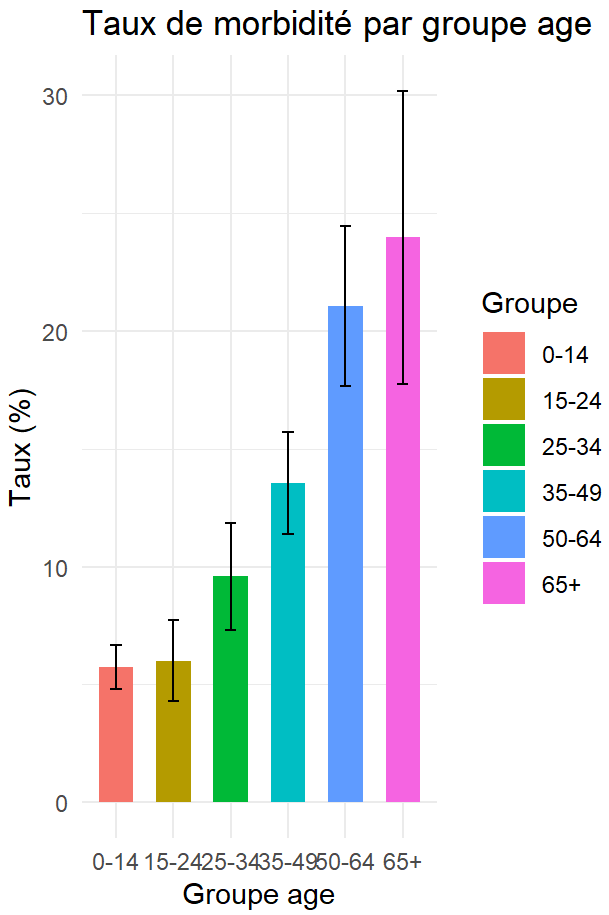
2.3 Methodes statistiques

Les analyses suivantes ont ete réalisées : Taux de morbidité avec intervalles de confiance a 95%, test du Chi-deux et V de Cramer pour les associations, test de Wilcoxon pour la comparaison de médianes, et visualisations : barplots, histogrammes, violin plots.

3 Question 13 - Taux de morbidité

3.1 Resultats



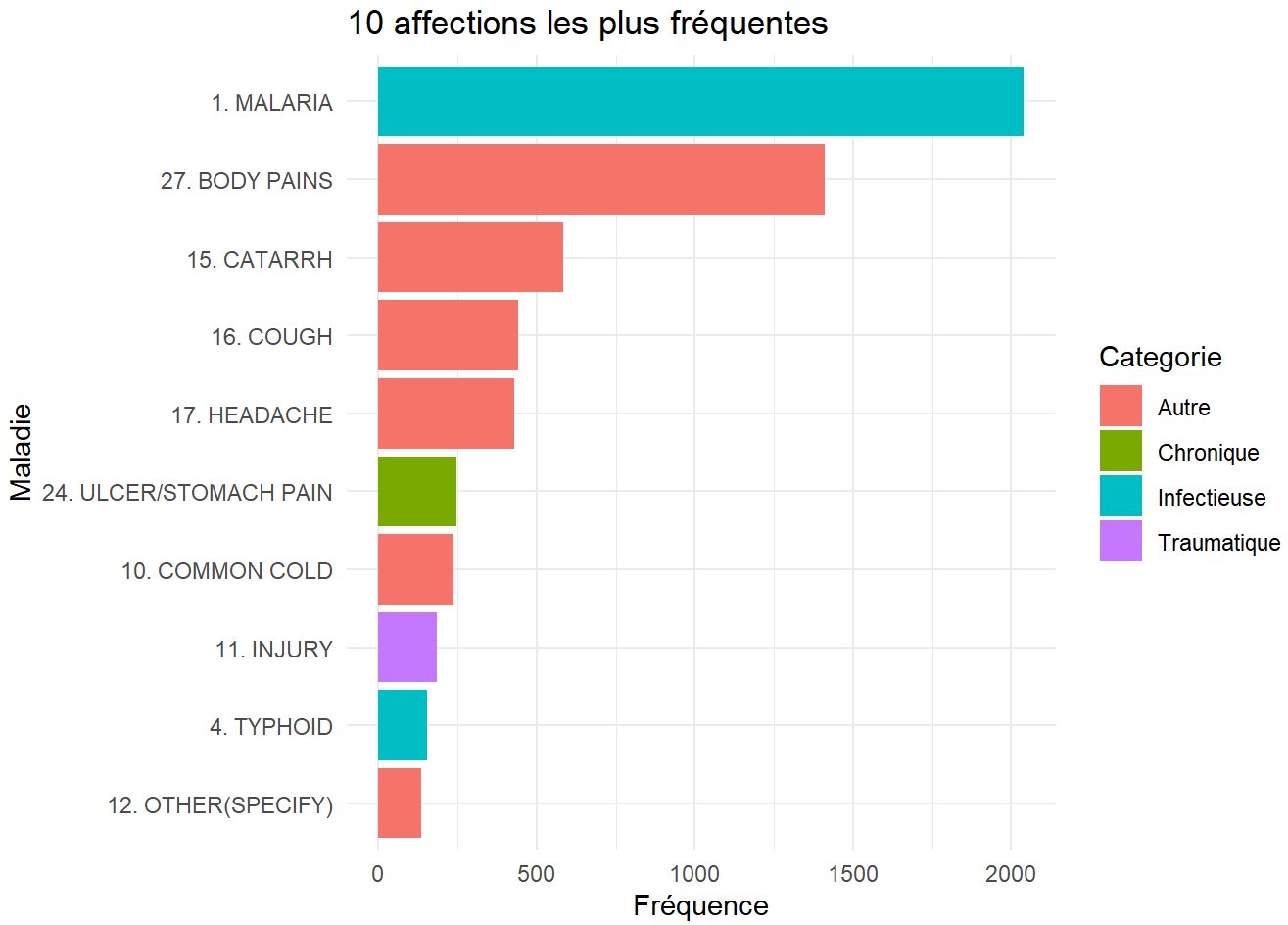


3.2 Interprétation

Le taux de morbidité global est de **9.31%**. Les femmes (**11.1%**) sont plus touchees que les hommes (**7.4%**). Le taux augmente avec l'age, passant de **5.7%** chez les 0-14 ans a **24%** chez les 65 ans et plus.

4 Question 14 - Types de maladies déclarées

4.1 Resultats

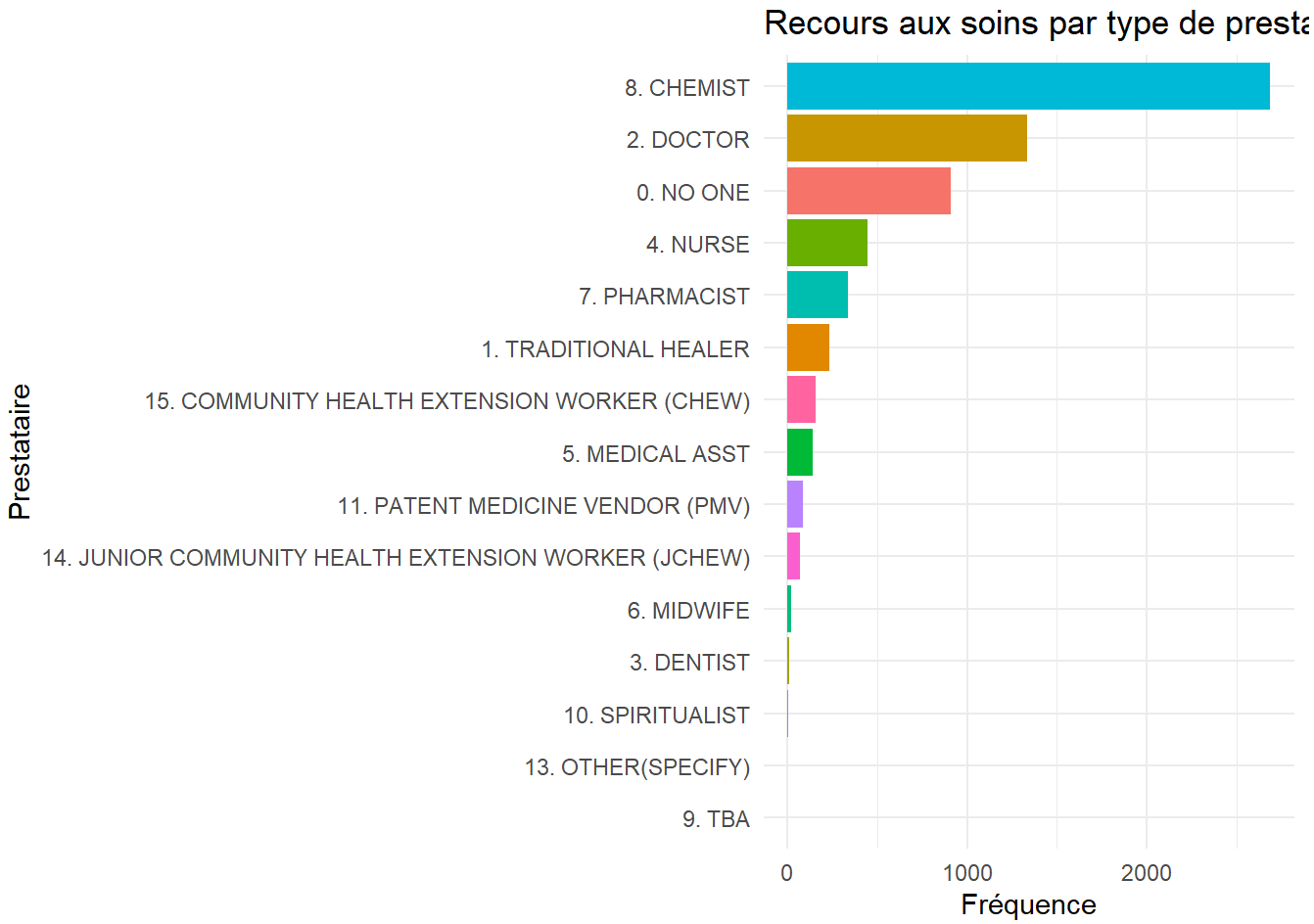


4.2 Interprétation

Le paludisme est la maladie la plus fréquente avec **2 039 cas (41.7%)**. Les douleurs corporelles arrivent en 2eme position (1 411 cas). Les maladies infectieuses dominent le profil epidemiologique du Nigeria.

5 Question 15 - Recours aux soins

5.1 Resultats

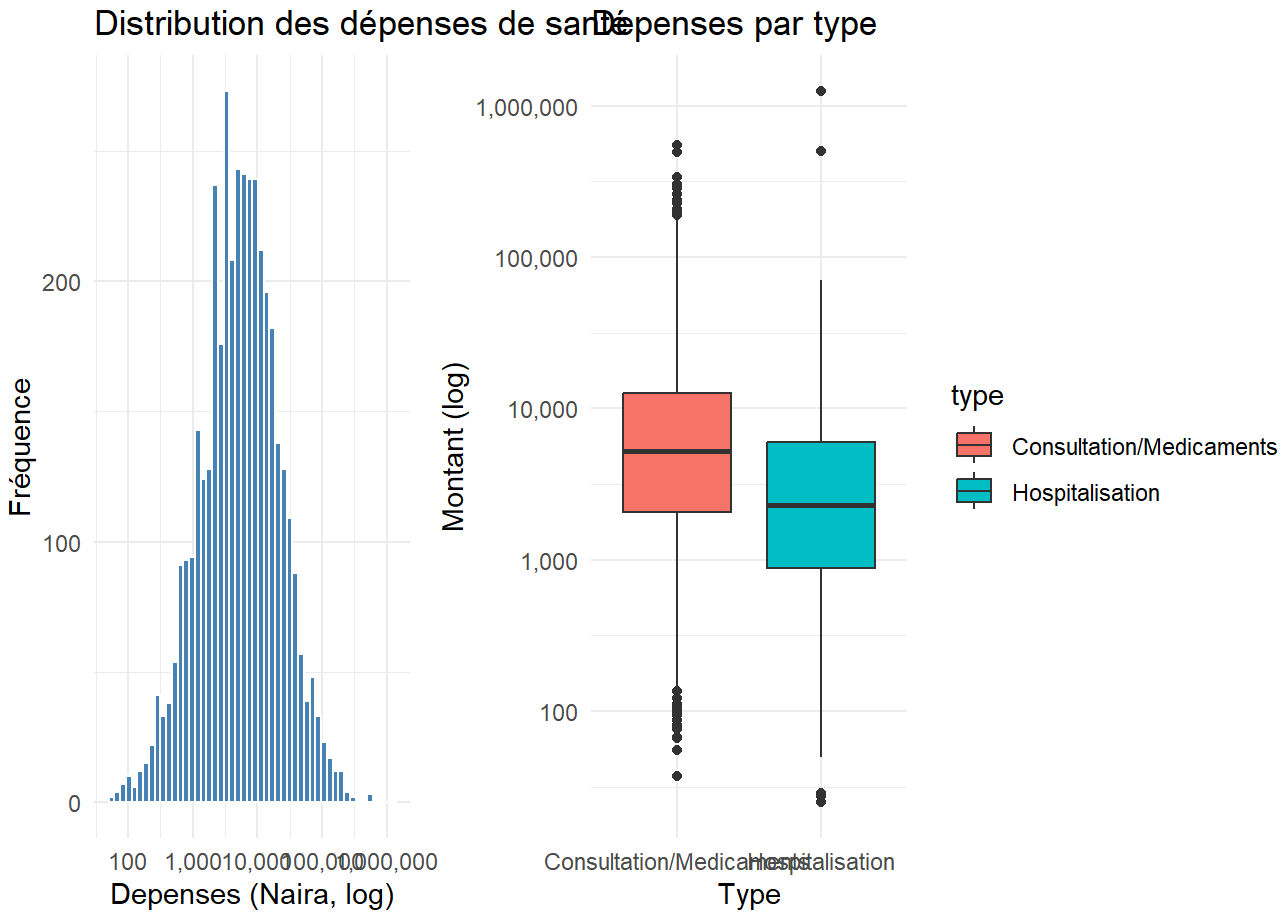


5.2 Interprétation

Le chimiste est le prestataire le plus consulte (**41.7%**), suivi du medecin (**20.7%**). **14.1%** des individus malades n'ont consulte personne, soulignant les barrieres d'acces aux soins.

6 Question 16 - Distribution des dépenses de santé

6.1 Resultats



6.2 Statistiques par decile

Depenses de santé par decile (Naira)

decile	Min	Mediane	Max	Moyenne
1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0
2	0.0000	0.0000	304.1667	37.1
3	304.1667	735.8333	1216.6667	746.6
4	1216.6667	1825.0000	2433.3333	1787.4
5	2433.3333	3041.6667	3650.0001	3011.5
6	3650.0001	4623.3332	5779.1666	4639.0
7	5779.1669	7097.2220	8533.3335	7094.3
8	8550.0000	10950.0000	13909.1668	11041.9
9	13991.6665	18250.0000	26158.3339	18883.2
10	26158.3340	43191.6680	1250000.0000	66449.6

6.3 Interprétation

Les dépenses de santé presentent une distribution fortement asymetrique. La médiane est de **3 650 Naira** avec **494 valeurs aberrantes**. Les dépenses d'hospitalisation sont plus dispersees que les consultations.

7 Question 17 - Recours aux soins x Quintile

7.1 Resultats

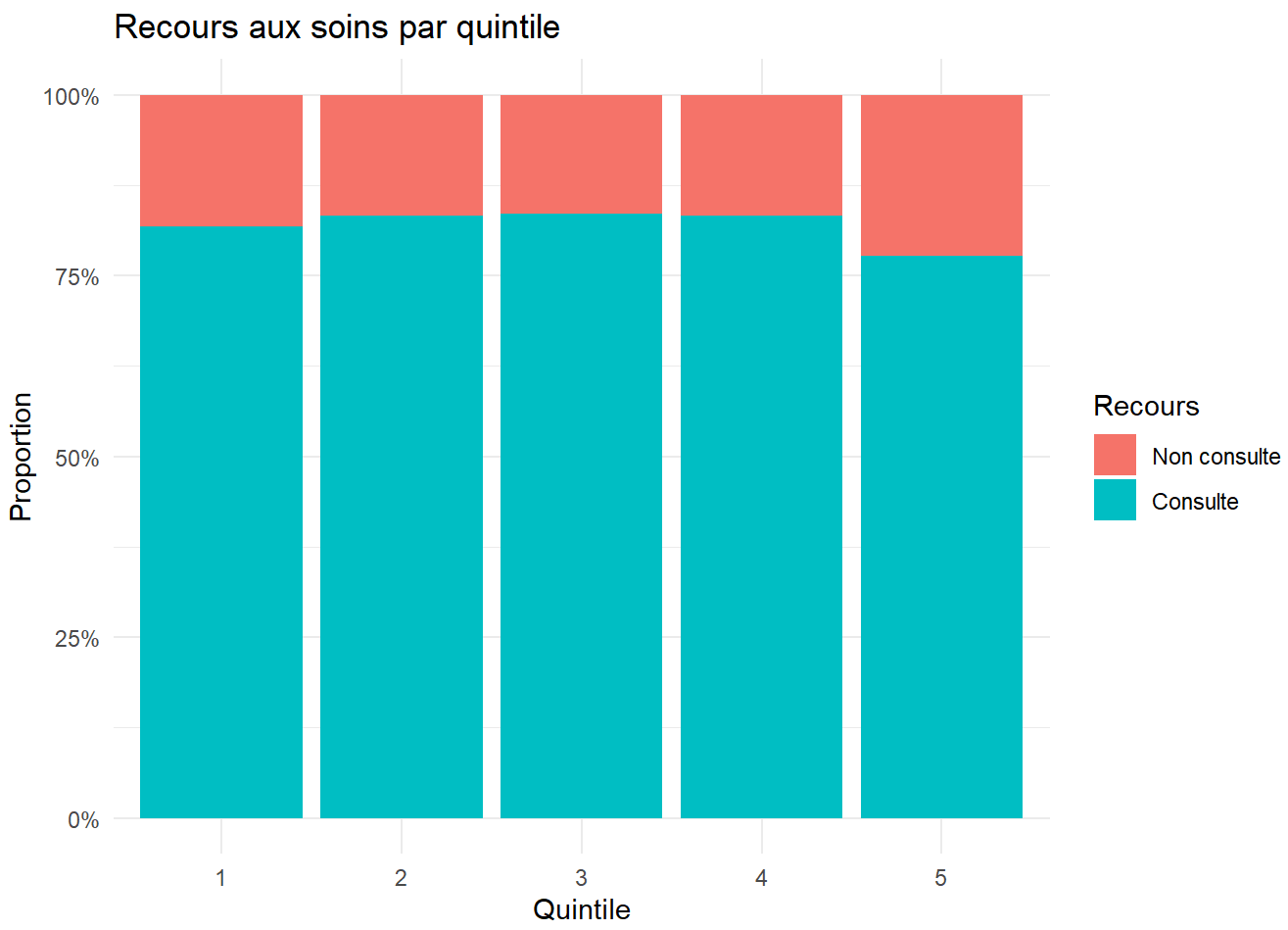
Tableau de contingence recours x quintile

	1	2	3	4	5
Non consulte	181	166	163	167	221
Consulte	815	829	832	828	774

```
Chi-deux: 15.865

p-value: 0.0032

V de Cramer: 0.0565
```

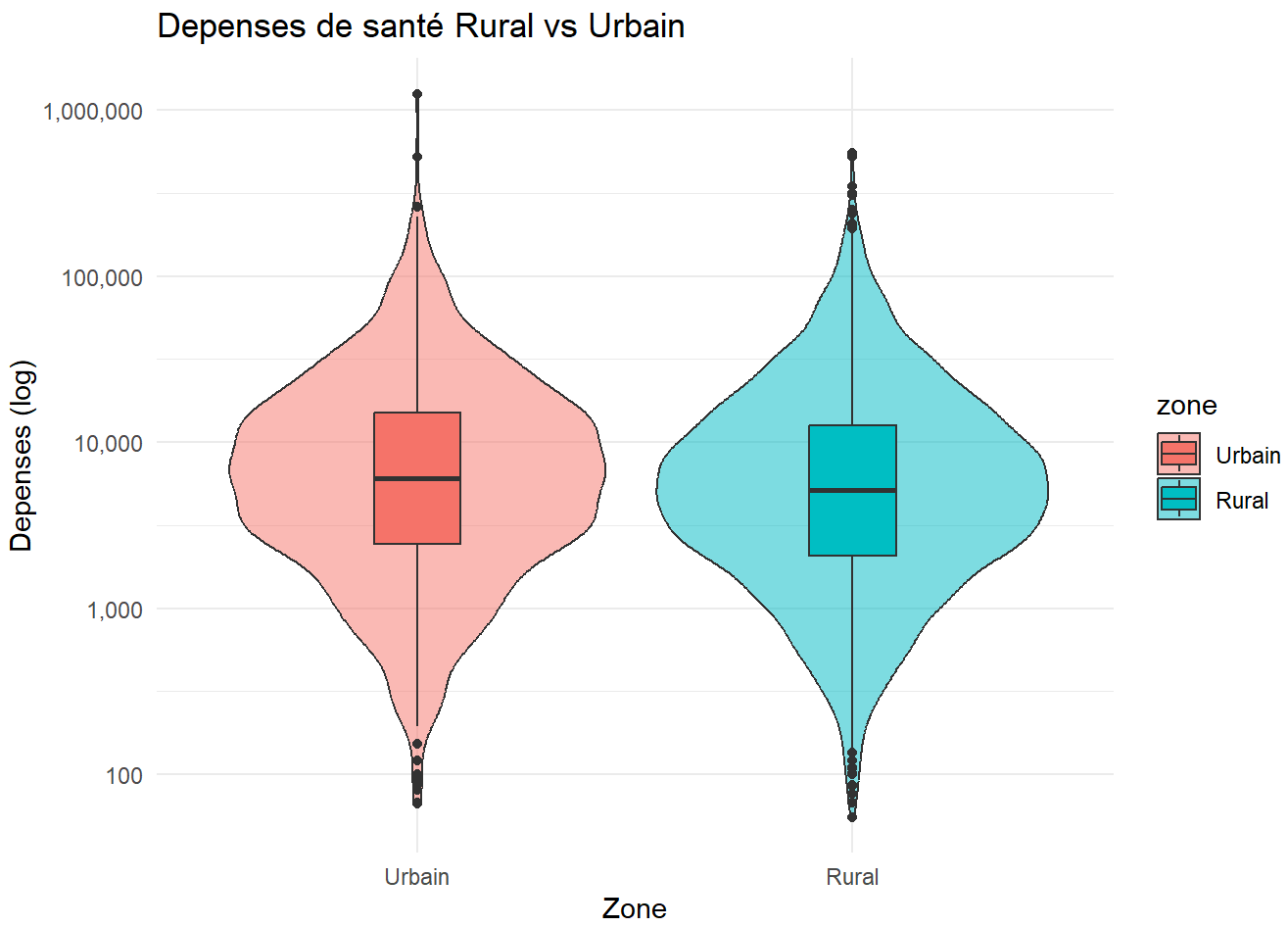


7.2 Interprétation

Le test du Chi-deux est significatif (**p = 0.003**), indiquant une association entre le recours aux soins et le quintile de consommation. Le V de Cramer (**0.056**) revele une association faible. Les menages les plus pauvres ont legerement moins recours aux soins.

8 Question 18 - Depenses de santé Rural vs Urbain

8.1 Resultats




```
Wilcoxon W: 2681342

p-value: 0.7937
```

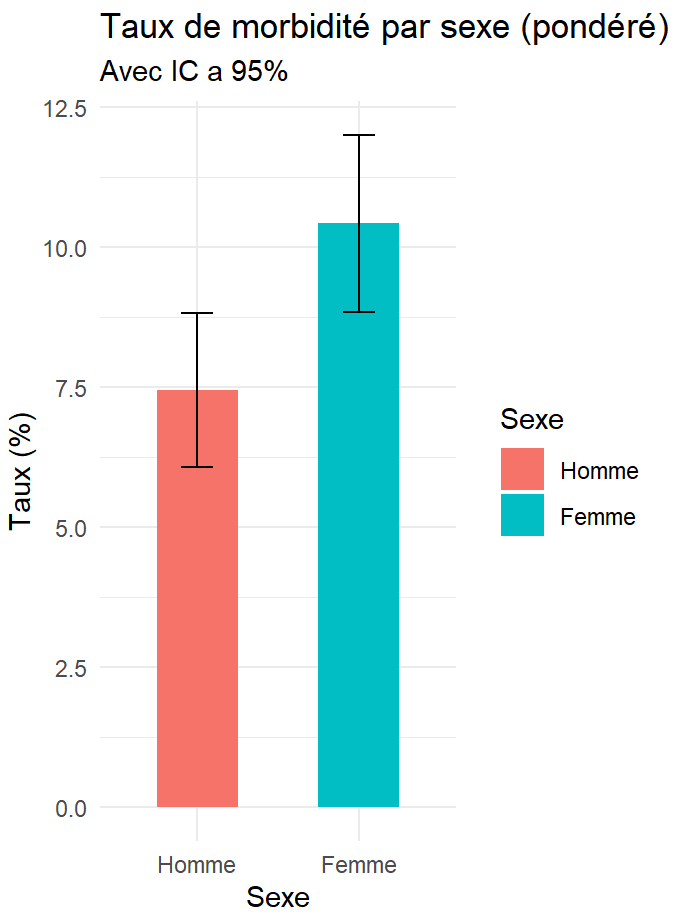
8.2 Interprétation

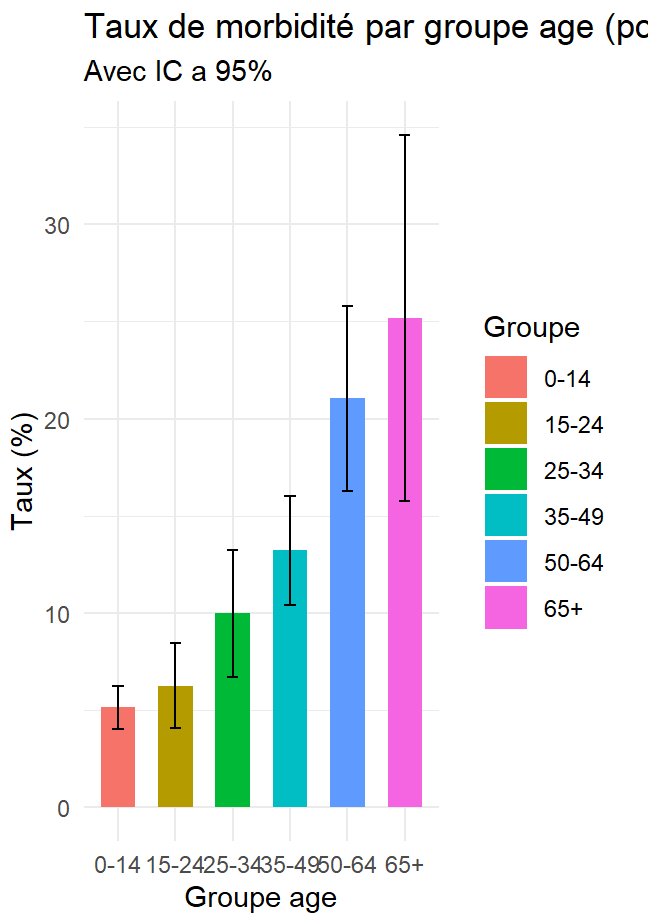
Le test de Wilcoxon (**p = 0.794**) ne montre pas de difference significative des dépenses de santé entre zones rurales et urbaines. Le violin plot confirme des distributions similaires dans les deux zones.

9 Analyses pondérées

Les analyses précédentes ne tenaient pas compte du plan de sondage. Nous intégrons ici les pondérations pour obtenir des estimations représentatives de la population nigériane.

9.1 Q13 pondéré — Taux de morbidité

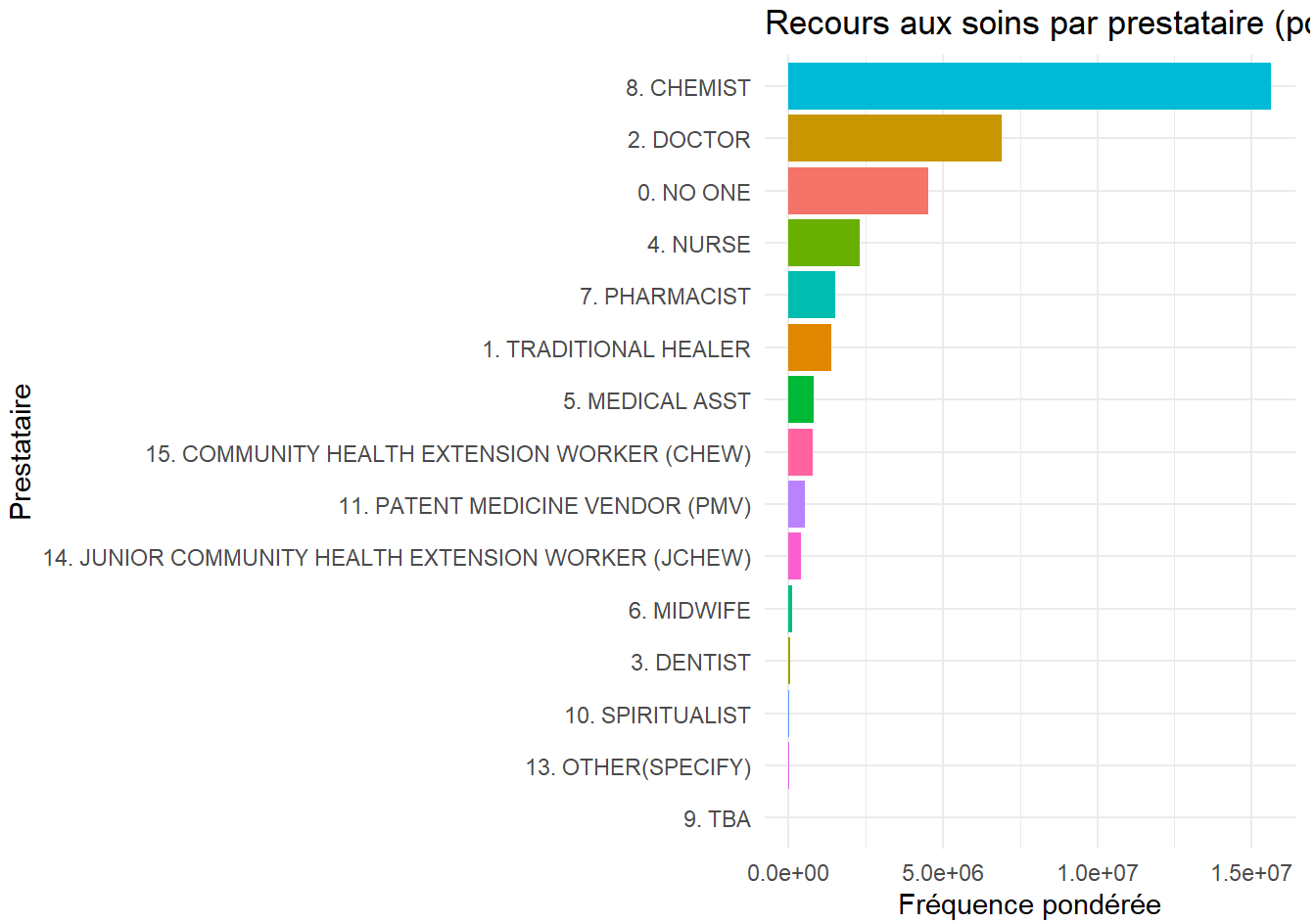




9.2 Interprétation Q13 pondéré

Le taux de morbidité pondéré global est de **8.66%** contre **9.31%** sans pondération. Les femmes restent plus touchées (**10.4%**) que les hommes (**7.4%**). Le taux augmente avec l'âge atteignant **25.2%** chez les 65 ans et plus.

9.3 Q15 pondéré — Recours aux soins



9.4 Interprétation Q15 pondéré

Après pondération le chimiste reste le prestataire le plus consulté. Les estimations pondérées sont plus représentatives de la population nigériane que les fréquences brutes.

9.5 Q17 pondéré — Recours aux soins × Quintile

Tableau de contingence pondéré recours x quintile

	1	2	3	4	5
Non consulte	37237345	26796001	22182645	17094457	10644168
Consulte	2772143	2190515	2320530	2012905	1502694

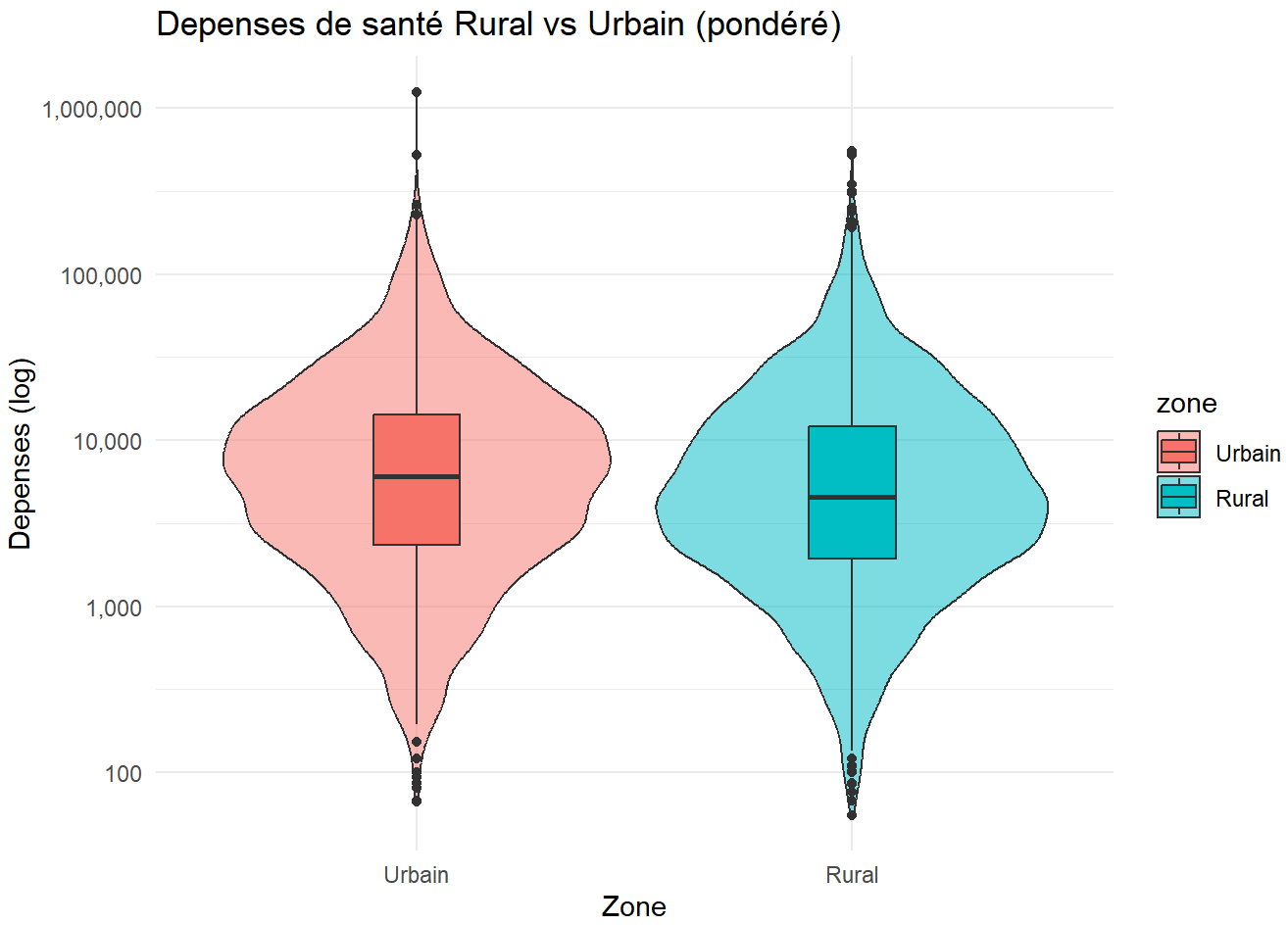
```
Chi-deux pondéré: 7.048

p-value: 0
```

9.6 Interprétation Q17 pondéré

Le test du Chi-deux pondéré confirme l'association entre recours aux soins et quintile de consommation. Les estimations pondérées sont plus précises car elles tiennent compte du plan de sondage.

9.7 Q18 pondéré — Dépenses santé Rural vs Urbain




```
Wilcoxon pondéré W: 0

p-value: 0.9825
```

9.8 Interprétation Q18 pondéré

Le test de Wilcoxon pondéré confirme l'absence de différence significative des dépenses de santé entre zones rurales et urbaines. Les résultats sont robustes après prise en compte des pondérations. # Conclusion

Cette analyse des données de santé du Nigeria GHS Panel Wave 4 revele :

- Un taux de morbidité global de **9.31%**, plus eleve chez les femmes et les personnes agees
- Le **paludisme** comme principale affection (**41.7%** des cas)
- Le **chimiste** comme premier recours aux soins (**41.7%**)
- **14.1%** des malades ne consultent personne
- Un lien significatif mais faible entre richesse et recours aux soins

- Pas de difference significative des dépenses entre zones rurales et urbaines

Ces resultats soulignent la necessite de renforcer l’acces aux soins formels et de lutter contre le paludisme au Nigeria.